



Distrito Córdoba y Guadalquivir
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

v_01 (15 de Marzo de 2021)

DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR

Durante este último año de pandemia y por las circunstancias especiales en las que se ha prestado atención sanitaria a los pacientes, han sido muchos los que han tenido dificultades para acceder al programa de deshabituación tabáquica en los centros de salud.

El programa de deshabituación tabáquica forma parte de la Cartera de Servicios de los centros de atención primaria y en él se realizan intervenciones tanto a nivel conductual como farmacológico.

Para obtener el máximo rendimiento a las intervenciones es imprescindible que los pacientes tengan motivación expresa para dejar de fumar, debiendo constatarse un intento de dejar de fumar en el último año.

Con el inicio a principios de año pasado de la financiación de tratamientos farmacológicos con Bupropion y Vareniclina para la deshabituación tabáquica, fueron muchos los pacientes que solicitaron ayuda para el abandono del hábito tabáquico con estos fármacos, si bien debían cumplir una serie de **requisitos imprescindibles** como son:

- Consumo de tabaco superior a 10 cigarrillos al día.
- Test de dependencia a la nicotina (Test de Fagerstrom) superior o igual a 7.
- Estar incluidos en programas de deshabituación.

Para poder atender de forma eficiente a estos pacientes en las consultas de atención primaria, todos los centros garantizarán su asistencia, que podrá hacerse tanto a nivel individual como grupal y para lo que también podrán contar con los profesionales de las Unidades de Dependencias y Adicciones (UDA) que pasan consulta en los centros de salud. Igualmente, los centros de atención primaria garantizarán la atención a los pacientes que puedan remitirse desde atención hospitalaria.

1.- ¿QUIÉN ATIENDE AL PACIENTE QUE SOLICITA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA?

En función del tipo de paciente (**Anexo-1**), la intervención se realizará por:

A. PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD

Atenderán como norma a la población general que solicite ayuda para deshabituación tabáquica, pudiendo derivar para apoyo y refuerzo psicológico a los profesionales de la UDA a pacientes que hayan tenido intentos y recaídas anteriores.

También atenderán de forma inicial, a los pacientes con patología relacionada con el consumo de tabaco y alto RCV, pudiendo igualmente remitir para apoyo y refuerzo psicológico a los profesionales de la UDA a pacientes complejos (**Anexo-2**)

B. PROFESIONALES DE LA UDA

Atenderán de forma general a pacientes que además del consumo de tabaco tengan o hayan tenido otras adicciones, mujeres embarazadas, pacientes con diagnóstico de trastorno mental grave, menores, reclusos en instituciones penitenciarias y pacientes en riesgo de exclusión social.

2.- ¿CÓMO SE ACCEDE AL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA?

Cada centro tendrá identificados los circuitos para remitir a los pacientes a las consultas del programa de deshabituación. Así, en función de dónde se identifique y capte al paciente (**Anexo-3**) se procederá:

A. PACIENTE QUE CONSULTA EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (UAC).

Estos pacientes que consultan inicialmente en las UACs de los centros, serán remitidos a las consultas de sus médicos de familia quienes harán una valoración del estado de preparación para el abandono del hábito tabáquico así como el test de Fagerstrom que permita conocer el grado de dependencia a la nicotina.

Una vez valorados y en caso de que sean candidato a incluirse en un programa de deshabituación, se les informará sobre las posibilidades, Individual o Grupal, procediendo a la citación en el programa por el que hayan optado.

Si el centro no existieran terapias grupales para deshabituación, será el médico o enfermero de familia del paciente en encargado de planificar las sesiones de deshabituación, presenciales o telefónicas, ya que la Deshabituación Tabáquica forma parte de la Cartera de Servicios básica de Atención Primaria.

B. PACIENTE QUE SE CAPTA EN LA CONSULTA DE MÉDICINA DE FAMILIA O ENFERMERÍA.

Cuando los pacientes sean captados directamente en las consultas de medicina o enfermería, y tras las valoraciones mencionadas con anterioridad, los pacientes serán citados en los programas de intervención de cada centro de salud, ya sea en agendas dispensarizadas individuales o grupales, si así lo tiene dispuesto el centro, o en la propia agenda del médico o enfermero que va a hacer la intervención.

C. PACIENTE QUE SE CAPTA EN HOSPITAL (CONSULTAS EXTERNAS O ALTAS HOSPITALARIAS)

Cuando sean los profesionales de hospital los que identifiquen a este tipo de pacientes, y una vez realizadas las valoraciones anteriores, indicarán al paciente que solicite cita para los programas de deshabituación tabáquica de los centros de salud a través de Salud Responde, quienes, mediante la aplicación de Backoffice transferirán la solicitud a cada centro de salud.

Por su parte, los Jefes de Grupo de los centros de salud harán revisiones periódicas de la aplicación de forma que todos los pacientes que hayan solicitado cita para deshabituación en su centro de salud a través de Salud Responde obtengan información de la cita en menos de 3 días laborables.

3.- ¿CÚANDO Y COMO SE VALORA LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA LA DESHABITUACIÓN?

Tras la inclusión del paciente en los programas de deshabituación y con independencia del profesional que los atienda, tras la cuarta sesión será revaluado y se tomará la decisión de si procede o no la prescripción financiada de Bupropion o Vareniclina (**Anexo-4**), o si por el contrario continuará con terapias conductuales sin precisar tratamiento farmacológico.

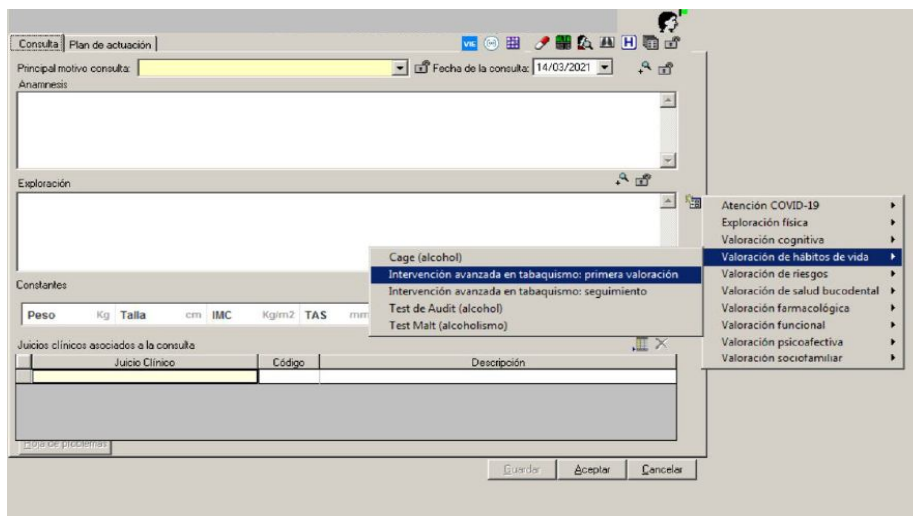
En el caso de que se decida que procede el tratamiento financiado, el profesional que haya realizado la intervención de deshabituación, lo citará con su médico de familia para que proceda a la prescripción, solo por un mes, pasado el cual, deberá ser revaluada su adherencia y efectividad, y en caso afirmativo, procederá a una nueva receta hasta finalizar el tratamiento financiado.

4.- ¿REQUISITOS PARA EL VISADO Y FINANCIACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA LA DESHABITUACIÓN?

El tratamiento farmacológico financiado para la deshabituación tabáquica con Bupropion o Vareniclina está sometido a visado por el área de farmacia del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, y serán los farmacéuticos los encargados de velar por el cumplimiento de los requisitos necesarios para su financiación recogiendo la información necesaria de la Historia de Salud del Usuario.

A. CUMPLIMENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE INTERVENCIÓN AVANZADA EN TABAQUISMO: PRIMERA VALORACIÓN.

De obligado cumplimiento. Disponible en las herramientas de ayuda a la exploración dentro de la “Valoración de los hábitos de vida”.



En esta hoja de registro se recogen los datos del test de Fagerstrom y el número de cigarrillos al día, obteniéndose al final del cuestionario información sobre la indicación para financiación o no del tratamiento farmacológico

B. CUMPLIMENTACIÓN DE HOJAS DE SEGUIMIENTO EN CONSULTA (HSC)

El profesional que realiza la intervención hará una HSC por cada una de las sesiones realizadas debiendo tener al menos 4 registros de sesiones realizadas antes de solicitar el visado para la financiación del tratamiento farmacológico.

De las 4 sesiones, la primera será siempre la que tenga realizado el cuestionario de Primera Valoración.

En cada HSC de las 3 sesiones restantes se hará una breve descripción de la sesión, reflejando los acuerdos adoptados y la situación del paciente. Estas HSC deberán estar separadas entre 5-7 días entre una sesión y otra.

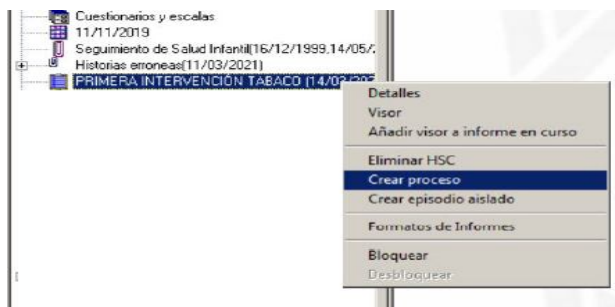
En el caso de pacientes que hayan precisado la colaboración o intervención directa de los profesionales de la UDA que trabajan en nuestros centros, si tras las correspondientes visitas de seguimiento se opta por la deshabituación farmacológica, enviarán al médico de familia del paciente un documento en el que se haga constar el motivo por el que el paciente ha sido atendido en la UDA, el resultado del test de Fagerstrom y en número de cigarrillos que consume el paciente (**Anexo-5**).

Por su parte el Médico de Familia, prescribirá el fármaco y realizará una HSC con la cumplimentación del Cuestionario de Primera Valoración, y este documento, junto con el aportado por el profesional de la UDA serán enviados por correo electrónico al área de farmacia del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir (DSCG) para su visado.

C. INCLUSIÓN EN CLIP DE PROCESO (OPCIONAL)

Para facilitar la localización de los episodios, se aconseja incluirlos dentro de un clip de proceso.

Para ello, a partir de una HSC, botón derecho y señalar “Crear proceso”



Al finalizar, se comprobará que se ha creado el “clip” de proceso y que la historia está dentro del “clip”



5.- ¿CÓMO SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL VISADO?

La solicitud de visado será detectada por el área de farmacia al realizarse la prescripción, y solo en el caso de pacientes atendidos por la UDA, se precisará el envío del documento correspondiente.

En caso de incidencias, la prescripción se notificará al médico prescriptor a través del Buzón del profesional. Al profesional le aparecerá como "Pendiente de datos" y se le indicarán los motivos por los que no se ha procedido al visado en ese momento.

A. EN PACIENTES INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS DE DESHABITUACIÓN.

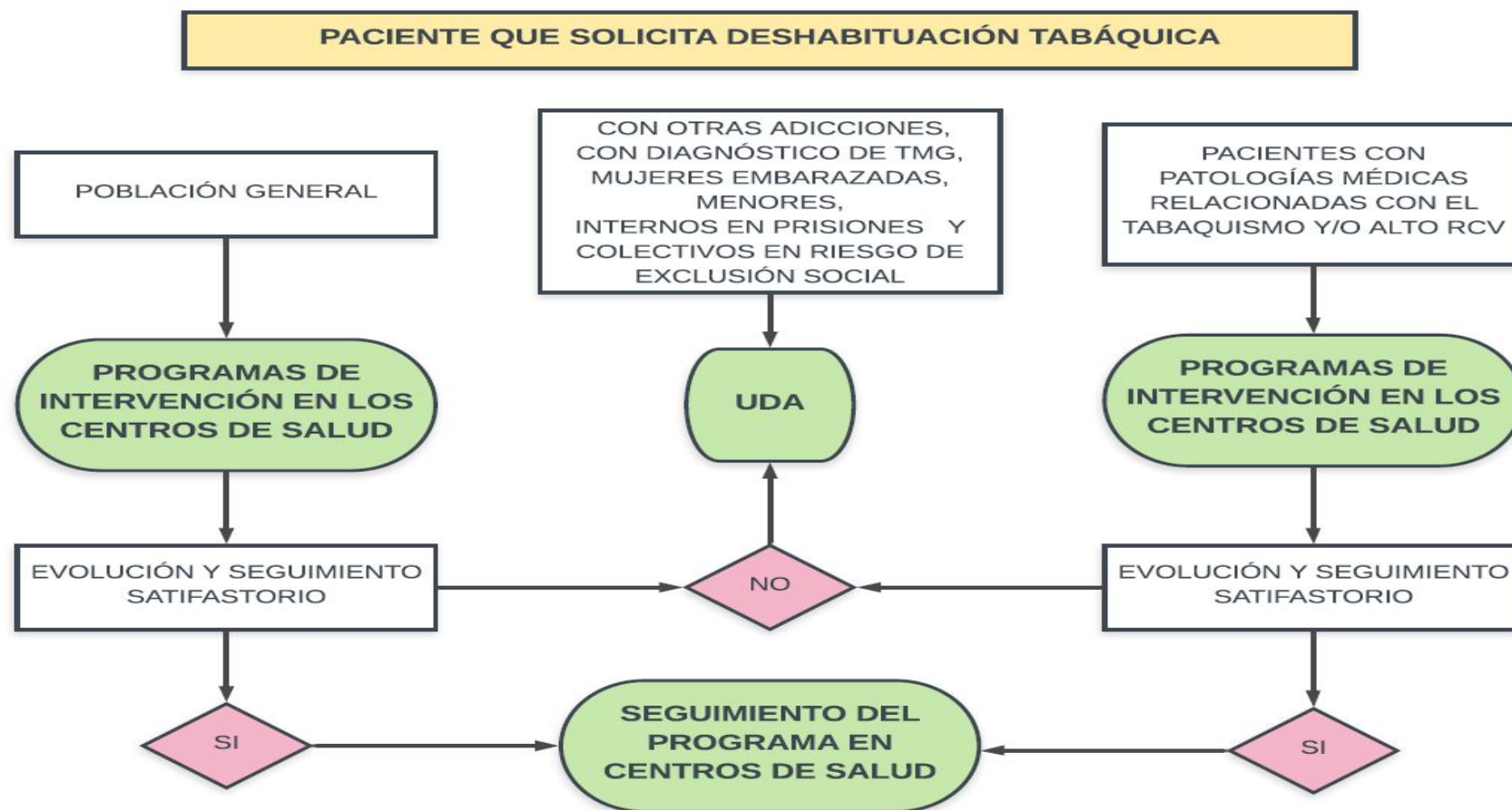
Los pacientes atendidos por los profesionales del Centro de Salud tendrán registrados los correspondientes episodios de las sesiones de deshabituación, por lo que no será necesario el envío de ninguna documentación, y serán los responsables del área de

farmacia los que comprobarán en la historia del paciente que este cumple con los requisitos establecidos.

B. EN PACIENTES ATENDIDOS POR LA UDA

Dado que los pacientes atendidos por la UDA no pueden hacer registros en la Historia de Salud del Usuario, habiéndose confirmado que el paciente cumple con los requisitos necesarios para la financiación del tratamiento farmacológico, se enviará a través de la UAC y mediante correo electrónico al área de farmacia del DSCG, el **Informe del Programa de Deshabituación tabáquica cumplimentado por la UDA (Anexo-5)** a la vez que su Médico de Familia cumplimenta la prescripción en RXXI

ANEXO 1



ANEXO 2

DERIVACIÓN A UDA PARA PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

- **Identificación del paciente:** AN_____

- **Motivo por el que se deriva a UDA:**

	Tabaco y otras adicciones
	Pacientes con diagnóstico de Trastorno Mental Grave
	Embarazadas
	Menores
	Internos en prisiones
	Población en riesgo de exclusión social.
	Pacientes con patología relacionada con el tabaco y alto RCV con mala evolución
	Población general con recaídas frecuentes

- **Resultado test de Fagerstrom:** _____

- **Consumo de cigarrillos al día:** _____

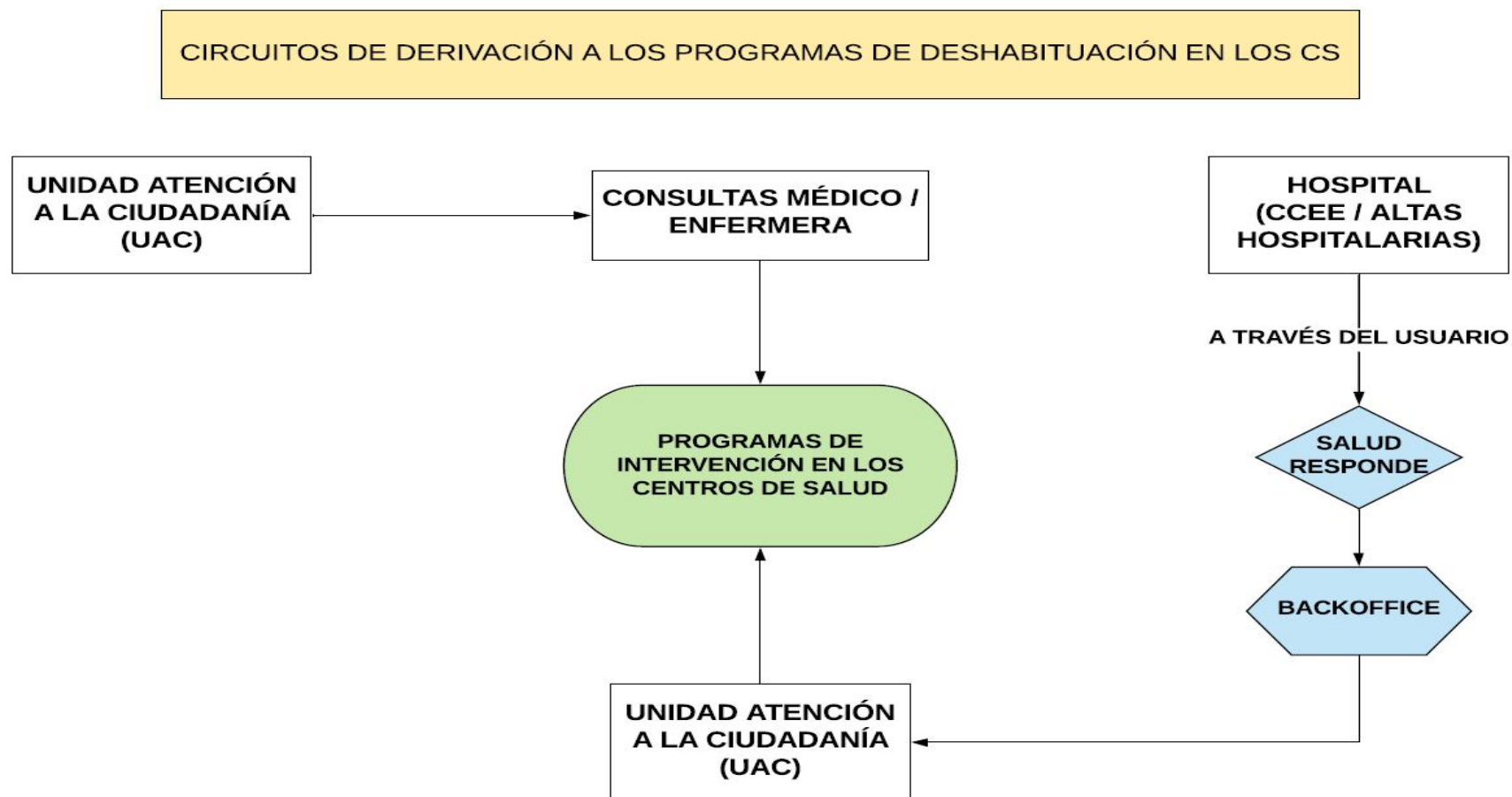
Tras la valoración del estado del paciente (PREPARADO PARA LA ACCIÓN) y estando incluido en los grupos indicados se solicita el seguimiento en el programa de deshabituación tabáquica por parte de la UDA

En Córdoba a ____ de _____ de 20__

Fdo: _____

Médico /Enfermera Familia
(Responsable del Programa)

ANEXO 3



ANEXO 4

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE FINANCIACIÓN DE MEDICACIÓN PARA LA DESHABITUACIÓN DEL TABACO (CHAMPIX Y ZYNTABAC)

En relación a la prescripción y financiación de los medicamentos Vareniclina y Bupropión para el tratamiento de la deshabituación tabáquica, desde el 1 de Enero de 2020, se autoriza la financiación de los mismos siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- ✓ Que el paciente esté incluido en un programa de apoyo de deshabituación tabáquica (individual y/o grupal): Se constatará la fidelización al programa si el paciente acude como mínimo a las 4 primeras sesiones. (Directriz del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir de Enero 2020). Se comprobará de cara a validar la prescripción, los registros en Historia Clínica de Salud. (Hojas de consulta Intervención avanzada Tabaquismo).
- ✓ Que tenga un alto nivel de dependencia calificado por el test de Fagerström ≥ 7 .
- ✓ Que haya habido un intento de dejar de fumar en el último año.
- ✓ Que fume 10 cigarrillos o más al día.

A partir del día 1 de septiembre de 2020, previo a la dispensación de estos medicamentos, se solicitará una validación de la prescripción, de forma que se garanticen las condiciones establecidas para su financiación. (ésta validación la realizará el Servicio de Farmacia del Distrito a través del Procedimiento de Visado de Medicamentos).

Para validar dicho tratamiento, el médico prescriptor deberá cumplimentar los formularios que se han diseñado para tal fin desde el Plan Integral del Tabaquismo de Andalucía (PITA) y que se encuentran incluidos en la HSC de Diraya.

De la misma manera, habrá que cerciorarse de dejar reflejo en la Historia de todas las sesiones de intervención avanzada realizadas con la persona. Si no se constata que dicho formulario está cumplimentado, y no existe registro de Sesiones de Intervención avanzada, la prescripción se quedaría sin autorizar o validar, hasta que se cumpliesen todos los requisitos.

Un tratamiento concreto requerirá las siguientes validaciones en función del medicamento prescrito:

Vareniclina.

Validación en la 1ª prescripción (VARENICLINA 500MCG / VARENICLINA 1MG) 1 envase, duración tratamiento 28 días

Validación en la 2ª prescripción (VARENICLINA 1MG, 56 COMPRIMIDOS) 1 comprimido cada: 12 horas, duración tratamiento: 28 días

Tercera prescripción: Tras la segunda prescripción, si el médico realiza una renovación del tratamiento, no requerirá validación. Solo habrá que proceder a una nueva validación si realiza una tercera prescripción, que deberá ser idéntica a la segunda.

Bupropión

Validación en la 1ª prescripción (ZYNTABAC 150MG 60 COMPRIMIDOS LIBERACIÓN PROLONG) 1 comprimido cada: 12 horas, duración tratamiento: 28 días

Segunda prescripción: Tras la primera prescripción, si el médico realiza una renovación del tratamiento, no requerirá validación. Solo habrá que proceder a una nueva validación si realiza una segunda prescripción, que deberá ser idéntica a la primera.

Se financiará un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico.

ANEXO 5

INFORME PROGRAMA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA_UDA

- **Identificación del paciente:** AN_____
- **Motivo por el que ha sido atendido en la UDA:**

	Tabaco y otras adicciones
	Pacientes con diagnóstico de Trastorno Mental Grave
	Embarazadas
	Menores
	Internos en prisiones
	Población en riesgo de exclusión social.
	Pacientes con patología relacionada con el tabaco y alto RCV con mala evolución
	Población general con recaídas frecuentes

- **Resultado test de Fagerstrom:** _____

Preguntas	Respuestas	Puntos
¿Cuánto tiempo tarda entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo?	Hasta 5 minutos	3
	Entre 6 y 30 minutos	2
	31-60 minutos	1
	Más de 60 minutos	0
¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido, como la biblioteca o el cine?	Sí	1
	No	0
¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar?	El primero de la mañana	1
	Cualquier otro	0
¿Cuántos cigarrillos fuma cada día?	10 ó menos	0
	11-20	1
	21-30	2
	31 ó más	3
¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de levantarse que durante el resto del día?	Sí	1
	No	0
¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día?	Sí	1
	No	0
PUNTUACIÓN TOTAL		

- **Consumo de cigarrillos al día:** _____

Tras la valoración y seguimiento en el programa de deshabituación tabáquica llevado a cabo en este paciente, se solicita la prescripción para su financiación de:

☐ CHAMPIX

☐ ZYNTACBAC

En Córdoba a ____ de _____ de 20__

Fdo: _____

Responsable UDA